SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
HSPE - Hospital do Servidor Público Estadual
Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000

PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE ENDOCARDITE HSPE – Jul 2022

MICRO-ORGANISMO	TRATAMENTO	
	VALVA NATIVA	VALVA PROSTÉTICA
1. *Streptococcus bovis (Streptococcus gallolyticus)* 2. *Streptococcus* grupo viridans **TEMPO DE TRATAMENTO** ***Valva nativa***: 4 semanas ***Valva prostética***: 6 semanas	***MIC penicilina < 0,125mg/L*** Pen. G cristalina 12-18 milhões UI/dia EV 4/4h ou 6/6h) ou Ampicilina (200 mg/Kg/dia EV 4/4h ou 6/6h) OU Ceftriaxone 1g EV 12/12h ***MIC penicilina > 0.25 até 2mg/L*** Pen. G cristalina 24 milhões UI/dia EV 4/4h ou 6/6h) ou Ampicilina (200 mg/Kg/dia EV 4/4h ou 6/6h) OU Ceftriaxone 1g EV 12/12h	***MIC penicilina < 0,125mg/L*** Pen. G cristalina 12-18 milhões UI/dia EV 4/4h ou 6/6h) ou Ampicilina (200 mg/Kg/dia EV 4/4h ou 6/6h) OU Ceftriaxone 1g EV 12/12h ***MIC penicilina > 0.25 até 2mg/L*** Pen. G cristalina 24 milhões UI/dia EV 4/4h ou 6/6h) ou Ampicilina (200 mg/Kg/dia EV 4/4h ou 6/6h) OU Ceftriaxone 1g EV 12/12h + Gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h (genta 2 semanas)
	VALVA NATIVA	VALVA PROSTÉTICA
1. *Staphylococcus aureus* 2. *Staphylococcus* coagulase negativo **TEMPO DE TRATAMENTO:** ***Valva nativa***: 4-6 semanas ***Valva prostética***: 6 semanas	*MSSA/MSSE* Oxacilina 3g EV 6/6h *MRSA/MRSE* Vancomicina 30mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) OU Daptomicina 10 mg/kg/dia EV 1x *(se MIC S. aureus ≥2)*	*MSSA/MSSE* Oxacilina 3g EV 6/6h + Rifampicina 300mg VO 8/8h + Gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h (genta 2 semanas) *MRSA/MRSE* Vancomicina 30mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) OU Daptomicina 10 mg/kg/dia EV 1x *(se MIC S. aureus ≥2)* COM Rifampicina 300mg VO 8/8h + Gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h (genta 2 semanas)

MICRO-ORGANISMO	TRATAMENTO	
	E. faecalis	*E. faecium*
***Enterococcus* spp.** ***Valva nativa*: 4-6 semanas** ***Valva prostética*: 6 semanas**	***Sensível a ampicilina*** **Ampicilina 200mg/Kg/dia EV 4/4h ou 6/6h + Ceftriaxone 2g EV 12/12h** ***R ampicilina S vancomicina*** **Vancomicina 30mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) + gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h** ***R ampicilina e R vancomicina*** **Daptomicina 10mg/kg/d EV 1x**	***Sensível a ampicilina*** **Ampicilina 200mg/Kg/dia EV 4/4h ou 6/6h + gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h** ***R ampicilina S vancomicina*** **Vancomicina 30mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) + gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h** ***R ampicilina e R vancomicina*** **Linezolida 600mg EV/VO 12/12h (tratamento 8 ou mais semanas)**
TRATAMENTO EMPÍRICO	***VALVA NATIVA*** **Ampicilina 12g/dia EV 4/4h ou 6/6h + Oxacilina 12g/dia EV 4/4h ou 6/6h + Gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h** **OU** **Vancomicina 30-60mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) + Gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h (paciente internado)** ***VALVA PROSTÉTICA*** **Vancomicina 30-60mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) + Gentamicina 3mg/kg/dia EV 8/8h + Rifampicina 300mg VO 8/8h (iniciar no 5º dia, após vanco + genta)** ***PACIENTE VALVA PROSTÉTICA E INSTÁVEL*** **Vancomicina 30-60mg/kg/dia EV 12/12h (vancocinemia alvo: 20 mcg/ml) + Meropenem 2g EV 8/8h + Rifampicina 300mg VO 8/8h (iniciar no 5º dia, após vanco + mero)**	

MICRO-ORGANISMO	TRATAMENTO
Candida ***Aspergillus***	**Anfotericina lipossomal 3mg/kg/dia** **OU** **Anfotericina complexo lipídico 5mg/kg/dia** **Indicação cirúrgica de urgência**
GRUPO HACEK ***Haemophilus parainfluenzae*** ***Aggregatibacter species*** ***Cardiobacterium hominis*** ***Eikenella corrodens*** ***Kingella species***	**Ceftriaxone 1g EV 12/12h por 4 semanas (valva nativa) ou 6 semanas (valva prostética)** **Se alta: Ciprofloxacina 500mg VO 12/12h**

Referências:

1) Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, Bongiorni MG, Casalta JP, Del Zotti F, Dulgheru R, El Khoury G, Erba PA, Iung B, Miro JM, Mulder BJ, Plonska-Gosciniak E, Price S, Roos-Hesselink J, Snygg-Martin U, Thuny F, Tornos Mas P, Vilacosta I, Zamorano JL; ESC Scientific Document Group. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128.

2) Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, Fowler VG Jr, Tleyjeh IM, Rybak MJ, Barsic B, Lockhart PB, Gewitz MH, Levison ME, Bolger AF, Steckelberg JM, Baltimore RS, Fink AM, O'Gara P, Taubert KA; American Heart Association Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and Stroke Council. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association. Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1435-86.

Serviço de Infectologia

GECIH